

14 - 04- Alcoolisme - Pr. MANOUDI

(0:02 - 0:48)

Bonjour, aujourd'hui on va traiter l'alcoolisme. Donc les objectifs, c'est définir un alcoolique selon l'OMS, reconnaître les manifestations neuropsychiatriques d'une intoxication aiguë, reconnaître les signes d'une imprégnation éthylique chronique, déterminer les signes de dépendance alcoolique, faire un bilan somatique devant un alcoolique, reconnaître les complications psychiatriques et diagnostiquer un délirium trimens, reconnaître les aspects thérapeutiques de l'alcoolisme chronique. Les alcooliques sont des buveurs excessifs dont la dépendance à l'égard de l'alcool conduit à une consommation responsable d'un trouble mental ou physique décelable et affectant le comportement, les relations sociales, familiales et le statut économique du sujet.

(0:48 - 1:09)

Là, on retrouve la définition dont on en a parlé dans le cours des addictions. Alors le mot alcool, il vient de l'arabe, c'est al-kuhul, c'est le phare à paupières et il y a une analogie entre l'utilisation des deux. Donc l'alcool, il est utilisé des fois pour cacher un malaise, pour cacher un problème, une souffrance.

(1:10 - 1:24)

Le phare à paupières, il est aussi utilisé pour cacher aussi une fatigue, un malaise ou quelque chose, donc pour apparaître mieux. L'alcool est un produit qui modifie l'état de conscience. Il a deux effets.

(1:24 - 1:48)

A petite dose, il a un effet anxiolytique qui est connu et un effet euphorisant. A forte dose, il entraîne une dépression du système nerveux central et il peut avoir aussi un effet stimulant, excitant. La recherche de modification de l'état de conscience, comme on a dit la dernière fois dans le cours des addictions, elle est universelle, ubiquitaire et humaine, donc partout, quelle que soit la société.

(1:49 - 2:11)

L'alcoolisme en lui-même n'est pas une maladie de produit, mais une maladie de la gestion du produit. On a des sujets qui boivent de l'alcool occasionnellement ou bien quotidiennement, mais ils n'ont pas de complications ni somatiques ni psychiques. Quelques informations sur l'alcool pour modifier des forces connaissances.

(2:12 - 2:29)

L'alcool, c'est quoi ? C'est la transformation d'une molécule chimique et l'éthanol, soit par

fermentation, soit par distillation. L'alcool, c'est une substance psychoactive qui agit sur le système nerveux central. Même si la production, la vente et l'usage de l'alcool sont réglementés, ça reste une drogue.

(2:31 - 2:51)

Effectivement, l'alcool, c'est une drogue parce qu'elle répond à la définition d'une drogue. Qu'est-ce que c'est une drogue ? C'est une substance qui entraîne une dépendance et qui, lorsqu'elle est absorbée, modifie une ou plusieurs des fonctions de l'organisme humain, particulièrement l'activité mentale et le comportement. Ce qu'on va voir dans les complications de la prise d'alcool, soit en aiguille, soit en chronique.

(2:52 - 3:17)

Pourquoi les sujets vont boire de l'alcool en particulier ? On a vu les causes de consommation des addictions dans le cours précédent. En particulier, l'alcool, c'est pour s'échapper à un quotidien qui est jugé insupportable, pour surmonter une inadaptation psychologique à la communication. L'alcool, il désinhibe et laisse les sujets avoir cette capacité de communiquer facilement avec les autres.

(3:17 - 3:37)

Il apaise une souffrance psychologique ou physique. Il permet aussi, et les gens l'utilisent, surtout les adolescents, pour transgresser les interdits et, bien sûr, pour avoir du plaisir. Et aussi, il y a des sujets qui prennent de l'alcool avec le désir de prendre le risque.

(3:39 - 4:05)

Donc, là, c'est une question, normalement, que vous devez répondre en direct. Donc, d'après vous, combien de verres repensez-vous par jour pour la femme et pour l'homme pour que les risques pour la santé commencent? Alors, pour la femme, c'est deux verres par jour. Donc, la femme ne supporte pas l'alcool par rapport à l'homme.

(4:05 - 4:33)

Pour l'homme, c'est trois verres par jour. Là aussi, c'est une question à répondre. Donc, là, selon vous, si vous avez à placer ces verres par ordre de quantité d'alcool, quel est le verre que vous allez mettre en premier et le verre en dernier? Donc, juste pour information, ils ont la même quantité d'alcool.

(4:34 - 4:47)

Une unité est égale à 10 grammes d'alcool. Parce qu'il y a des sujets qui vont minimiser leur prise d'alcool. Ils vont vous dire, par exemple, je ne prends qu'un verre de whisky, un petit verre

de whisky ou bien qu'un petit verre de passis.

(4:47 - 5:05)

Il faut savoir que, des fois, les verres ont la même quantité d'alcool. Et c'est aussi pour calculer le nombre d'unités d'alcool par bouteille. Le whisky n'est pas moins alcoolisé avec de l'eau, du soda ou du jus de fruits.

(5:05 - 5:11)

Cela ne fait que diluer le goût et l'alcool. Mais la quantité reste la même. Cela ne modifie pas la quantité.

(5:19 - 5:37)

Il faut attendre plusieurs heures en fonction du nombre de verres consommés. Environ une heure par verre. Si vous posez la question à un alcoolique, pourquoi vous buvez de l'alcool, la plupart vont répondre, j'éprouve le besoin de consommer pour me sentir mieux ou supprimer un mal-être.

(5:37 - 5:46)

On m'a déjà fait des remarques sur ma consommation. J'ai déjà eu l'impression que je buvais trop. J'ai eu besoin d'alcool dès le matin pour me sentir en forme.

(5:46 - 6:02)

Je suis anxieux et irritable si je ne consomme pas. Ma consommation perturbe ma vie personnelle, mes études, mon travail. Ce sont des questions qui laissent le sujet réfléchir sur les conséquences de l'alcool sur lui et sur sa famille et son entourage.

(6:05 - 6:16)

L'absorption de l'alcool est rapide et se fait au niveau de l'estomac, surtout le duodénum. On atteint un pic en une demi-heure. Il y a un ralentissement de l'absorption si l'estomac est plein.

(6:17 - 6:42)

Un verre standard donne 0,2 grammes d'alcool en une heure. La distribution est très rapide dans les organes, fortement vascularisés, lente dans les muscles et il y a absence de diffusion dans la graisse. C'est pour ça qu'on a une différence de tolérance de l'alcool entre les hommes et les femmes et entre les petits et les adultes.

(6:43 - 6:52)

L'élimination se fait après métabolisme oxydatif ou excrétion. Le métabolisme hépatique domine.

Il y a aussi un métabolisme gastrique.

(6:53 - 7:11)

Il y a un métabolisme par les bactéries coliques. L'excrétion se fait sous forme inchangée, faible au niveau des urines, l'air expiré qu'on mesure et au niveau de la sueur. Le métabolisme oxydatif est très important de le savoir.

(7:11 - 7:47)

L'alcool se transforme en acétaldéhyde par l'alcool des hydrogénases et l'acétaldéhyde, qui est une substance toxique, se transforme en acétate par l'acétaldéhyde des hydrogénases. Et puis, il y a la libération en CO₂ et H₂O. Ce métabolisme est très important à connaître parce que grâce à ce métabolisme, on a fabriqué une molécule qui va devenir un traitement pour dissuader les patients de prendre de l'alcool.

(7:47 - 8:26)

C'est un traitement dissuasif qu'on appelle dissuasif parce qu'il va empêcher les patients de prendre de l'alcool à cause des conséquences négatives si jamais ils prennent de l'alcool après la prise de ce médicament. Ce médicament va inhiber l'acétaldéhyde des hydrogénases ce qui va entraîner une accumulation de l'acétaldéhyde dans l'organisme, une substance toxique qui va entraîner des conséquences graves que le sujet ne va pas supporter. Cette molécule est très réactive et très toxique.

(8:26 - 8:32)

Elle augmente la production de radicaux libres. Elle inactive des agents antioxydants. Elle inactive les microtubules.

(8:33 - 8:47)

Elle active la production de collagène par les cellules étoilées. Elle augmente la production de cytokines. L'alcool entraîne aussi des lésions anatomiques avec réduction de la matière blanche au niveau du cortex, du cervelet et du corps calleux.

(8:48 - 8:57)

Une atrophie cérébrale avec délatation ventriculaire réversible après sevrage. Perte de neurones. Au niveau de l'hippocampe, elle peut entraîner un syndrome de Korsakoff.

(8:57 - 9:12)

On va voir les symptômes par la suite. L'effet neuropsychiatrique est en fonction de l'alcoolémie. Si on est à 0,1 à 0,3 g, le sujet ne peut pas présenter de troubles.

(9:13 - 9:31)

Mais quand il augmente la consommation, les troubles commencent à apparaître. Ils peuvent aller jusqu'à la mort quand on dépasse 5 g par litre d'alcoolémie. Les effets neuropsychiatriques Il y a les intoxications alcooliques aiguës et les intoxications alcooliques chroniques.

(9:31 - 10:10)

Dans les intoxications alcooliques aiguës, on note premièrement l'ivresse simple qui va se manifester par des signes neurologiques, des signes d'excitation psychomotrice avec altération des fonctions sensorielles, incoordination motrice, humeur qui est instable et labile, de la logurée, de la familiarité, de l'altération de l'activité intellectuelle et une levée d'inhibition comportementale. Ce sont des symptômes qui vous rappellent un peu l'accès maniaque. La deuxième complication de l'intoxication alcoolique aiguë est l'ivresse pathologique qui se forme de 4 formes.

(10:11 - 10:32)

La crise excitomotrice, l'ivresse hallucinatoire, le syndrome confuso délirant et l'ivresse avec troubles de l'humeur. Dans l'ivresse hallucinatoire, on a plus qu'au plus des hallucinations visuelles que des hallucinations auditives et des hallucinations olfactives. La troisième complication aiguë est le coma alcoolique.

(10:32 - 10:55)

C'est un coma qui est profond avec hypoglycémie. Faire très attention à l'hypoglycémie chez ces patients, l'hypothermie et on peut avoir d'autres complications comme par exemple un collapsus des crises épileptiques. Il peut y avoir de l'hépatite aiguë, de la pancréasite aiguë qui peut être mortelle, une hypercalémie, insuffisance rénale aiguë, dépression respiratoire et des pneumopathies par inhalation.

(10:55 - 11:11)

Tout cela peut entraîner la mort. Dans les complications alcooliques chroniques, on note en premier des signes d'imprégnation éthylique. Ce sont des signes qui vont se voir quand le sujet consomme plus de 10 ans.

(11:12 - 11:54)

Au niveau du visage, ça se voit. Ce sont des gens qui vont avoir un teint congestionné avec des téguments injectés, des petits vaisseaux au niveau de leur visage, les yeux sont bouffis, oedème de la paupière, les conjonctives, on peut avoir un subcône, ça montre déjà qu'il y a une atteinte hépatique, et puis avoir des tremblements au niveau de l'extrémité, surtout le matin au réveil parce que le sujet était en sevrage toute la nuit, ce qui les pousse à consommer dès le réveil, et bien sûr l'odeur de la laine alcoolisée. D'autres signes, notamment des troubles du sommeil, des

troubles neurologiques et des troubles psychiques peuvent apparaître pendant cette phase.

(11:55 - 12:31)

La deuxième complication est liée au sevrage. Dans les complications de sevrage, on note en premier le syndrome de sevrage, c'est après l'arrêt brutal de la consommation, le sujet va présenter à peu près 6 heures à 12 heures après l'arrêt ou la diminution de l'intoxication, et des fois, ce syndrome peut apparaître lors de l'ingestion massive d'alcool, lors d'un traumatisme crânien, d'une émotion violente ou lors d'un surmenage physique. Les symptômes atteignent leur maximum au bout de 24 à 48 heures et peuvent persister quelques jours.

(12:32 - 13:09)

Il est constitué par des signes neuromusculaires, des signes digestifs, des signes neurovégétatifs et des signes psychiques. Les deux autres complications liées au sevrage, donc il y a les crises d'épilepsie de sevrage qui vont apparaître 24 à 48 heures après un sevrage brutal et complet, surtout si on a des antécédents d'épilepsie ou de traumatisme crânien et peuvent constituer un mode de début au délirium tremens. Faites très attention à un patient que vous allez mettre sous sevrage.

(13:09 - 13:23)

Il faut toujours le mettre sous un traitement de sevrage qu'on va voir par la suite et ce sont les benzodiazépines. La troisième complication qui est liée au sevrage, c'est le délirium tremens. On va le voir un petit peu en détail.

(13:25 - 13:46)

Dans les autres complications chroniques, il y a les psychoses alcooliques. Dans les psychoses alcooliques, on note le délire aigu, c'est l'ivresse délirante du délirium tremens et il y a les délires chroniques. Dans les délires chroniques, il y a en premier les idées fixes post-onéroides, c'est la persistance d'un vécu onéroides.

(13:46 - 14:08)

Lors du délire chronique du délirium tremens, le patient peut garder une persistance d'un vécu onéroides. En général, ça disparaît, ça régresse en deux à trois mois. Il y a une plus longue durée s'il y a réactivation par de nouvelles expériences onéroides.

(14:08 - 14:55)

Si le sujet continue à consommer, il peut y avoir une prolongation de ces idées fixes post-onéroides. La deuxième complication du délire chronique est les hallucinations des buveurs de Wernicke, qui constituent par un ensemble d'hallucinations acoustico-verbales et un automatisme

mental, c'est un ensemble d'hallucinations que vous avez vu en sémiologie, avec une participation massive, une anxiété extrême et quand il y a la participation affective massive, le sujet peut passer à l'acte. Il ne critique pas son délire et les hallucinations peuvent avoir un contenu qui est hostile et menaçant.

(14:57 - 15:49)

L'évolution en général de ce type d'hallucinations, elle est favorable en quelques jours, à quelques semaines, ce traitement neuroleptique. Si il n'est pas traité, on peut passer à la chronicité. Et on va passer aux psychoses hallucinatoires chroniques des buveurs de Kreplin, qui est constitué par un automatisme mental, qui sont un ensemble d'hallucinations auditives, visuelles, synesthésiques et anesthésiques, des délires mal systématisés et le thème le plus fréquent, c'est la persécution ou la jalousie.

Et en dernier, on a le délire paranoïaque. C'est un délire systématisé, surtout thématique de jalousie, d'hypochondrie, d'homosexualité, avec une participation affective. Et quand il y a une participation affective, le sujet peut passer à l'acte hétéroagressif.

(15:51 - 16:08)

La quatrième complication du trouble de l'intoxication alcoolique chronique est le trouble de la personnalité. La personnalité peut être impliquée à la fois dans l'étiologie, dans la réponse au traitement, dans le pronostic. Elle va entraîner un mauvais pronostic et dans les complications de l'alcoolodépendance.

(16:11 - 16:40)

Selon Freud, l'alcoolisme est une fixation au stade oral. Vous avez vu au cours de cours de psychologie le stade oral, anal et éphatique pour lui. L'alcoolisme est la fixation au stade oral.

Le stade oral, c'est avoir du plaisir au niveau oral. Il a une dimension dépressive, autodestructive voire masochiste. Il n'a pas de caractère prédictif d'un type de personnalité.

(16:40 - 17:03)

On a un ensemble de traits, principalement de l'impulsivité, le manque de contrôle et l'intolérance à la frustration. On n'a pas vraiment une personnalité spécifique à l'alcool. L'instabilité ou l'irritabilité avec des réactions changeantes et imprévisibles vont entraîner une fragilisation des rapports sociaux.

(17:03 - 17:55)

On note chez ces sujets une apsignosie, absence d'autocritique touchant les rapports affectifs avec l'environnement, une régression affective avec exagération du narcissisme et des intérêts

progressifs pour l'entourage familial et une mauvaise connaissance de l'intoxication, c'est-à-dire un faible insight, une faible conscience des troubles. Dans les intoxications alcooliques chroniques, on voit aussi des complications psychiatriques notamment l'anxiété. Les troubles anxieux, un quart des patients anxieux ont recours à l'alcool et l'alcoolisme va entraîner 90% des symptômes anxieux isolés sous forme de tension, de peur, d'irritabilité et on a de 20 à 30% de cas de troubles anxieux caractérisés associés à l'alcoolisme, notamment le trouble d'anxiété généralisé, le trouble panique ou le trouble phobique.

(17:55 - 18:18)

Ce sont les plus fréquents. Dans le DSM-5, quand on a un trouble d'anxiété secondaire à la prise d'alcool, on parle de troubles anxieux induits par une substance. Ce trouble, on peut le trouver par exemple lors de l'anxiété de sevrage qui va arriver jusqu'à 4 semaines après l'arrêt ou de l'intoxication.

(18:20 - 18:34)

On a déjà parlé de l'anxiété de sevrage. L'anxiété primaire, elle peut aussi exister. Dans ce cas, l'alcoolisme est pris comme automédication d'un trouble anxieux.

(18:35 - 18:53)

Au début, le sujet a un trouble anxieux. Après, il va commencer à prendre l'alcool pour diminuer cette anxiété et il va tomber dans la dépendance à l'alcool. Les troubles anxieux existent avant toute conduite de dépendance où l'anxiété persiste au-delà d'un mois de sevrage.

(18:53 - 19:08)

On parle d'une anxiété dans ce cas primaire. Surtout, les cas les plus fréquents, c'est les phobies sociales et l'agoraphobie. L'alcoolisme renforce le sentiment de culpabilité, de dévalorisation et d'incapacité à affronter la situation phobogène.

(19:13 - 19:30)

L'alcool a un rôle biphasique sur l'anxiété. En cas de consommation aiguë, l'alcool va se fixer sur les récepteurs GABA ergiques et il va entraîner une diminution de l'anxiété. En consommation aiguë, il a un effet anxiolytique.

(19:31 - 19:55)

En consommation chronique, l'alcool diminue le nombre des récepteurs GABA et diminue la sensibilité des canaux chloriques. Donc, il a un effet anxiogène en consommation chronique. Par rapport à la dépression, la dépression augmente le nombre d'hospitalisations, aggrave les conséquences sociales et potentialise le risque suicidaire si il est associé à l'alcoolisme.

(19:56 - 20:12)

Principalement, elle est secondaire, parce que l'alcool est dépressogène. On a, dans 90% des cas, des symptômes dépressifs. De l'irritabilité, de une humeur dépressive, un abaissement de l'humeur.

(20:13 - 21:01)

On n'a pas tous les critères pour répondre à un épisode dépressif majeur. Dans 30% des cas, on a des états dépressifs supérieurs à 2 semaines, et dans 5% des cas, le patient va répondre à tous les critères d'un épisode dépressif majeur. L'alcool va modifier le métabolisme de neurotransmetteurs qui sont impliqués dans la dépression, notamment la noradrénaline, sérotonine et le GABA.

Elle entraîne un turnover augmenté lors de la consommation et diminue lors du sevrage. Elle entraîne une modification négative des taux cérébraux de sérotonine, corrélée à la fréquence des troubles dépressifs chez l'alcoolique. C'est comment l'alcool va entraîner une dépression.

(21:01 - 21:24)

La dépression primaire avant la consommation d'alcool, avant la dépendance à l'alcool, elle est rare. On la trouve dans 1 à 5% des cas, surtout chez la femme. L'alcool dépendance, l'alcoolodépendance dans les suites de dépression réactionnelle ou bien l'alcoolisation solitaire, plutôt vespérale, avec ivresse et culpabilité.

(21:26 - 21:41)

La relation avec le suicide, on note une mortalité par suicide chez les patients alcooliques qui peut aller jusqu'à 29% des cas. La dépendance alcoolique chez les patients suicidants est de 20 à 60% des cas. Dans ce cas, on a deux problèmes.

(21:41 - 22:02)

Premièrement, l'alcool constitue le potentiel suicidaire du patient alcoolique. Devant tout alcoolisme, il faut chercher une dépression et il faut chercher des idées suicidaires. La consommation d'alcool est beaucoup plus utilisée dans les tentatives de suicide.

(22:02 - 22:22)

Ça facilite le passage à l'acte suicidaire chez les patients. Les crises suicidaires en cas de consommation d'alcool se font de façon impulsive. L'association alcoolisme-dépression majeure le potentiel suicidaire et ça peut être même une indication à l'hospitalisation.

(22:22 - 22:45)

Une dépression chez un patient alcoolique, il faut chercher des idées suicidaires et il faut hospitaliser le patient. Cette association entraîne un court circuit comportemental entre le niveau de désespoir et le geste suicidaire. Le patient peut passer à l'acte de façon impulsive suite à un désespoir, à un problème minime.

(22:46 - 23:11)

Il y a d'autres facteurs de risque notamment le chômage, la séparation, les maladies somatiques, les troubles graves de la personnalité et quand on a un début d'intoxication précoce. Le suicide est le plus fréquent au décours de l'ivresse, du délire ou de confusion. 50% de patients consultant en urgence pour une tentative de suicide ont consommé de l'alcool.

(23:11 - 23:35)

Donc soit pour se donner du courage ou comme anesthésiant, l'alcool favorise les gestes à haute létalité comme on a dit tout à l'heure par phénomène de désinhibition. Il augmente l'impuissibilité et réduit le contrôle comportemental. Il y a aussi une potentialisation des effets toxiques des médicaments ingérés à visée suicidaire si il est associé à l'alcool.

(23:37 - 24:03)

On ne va pas s'attarder sur les complications neurologiques de l'alcool. Ce sont des pathologies que vous allez voir en neurologie. Il y a différents mécanismes soit par manifestation de l'intoxication aiguë, soit par manifestation du sevrage, soit par conséquences nutritionnelles, soit des pathologies qui sont mal connues, dues à l'alcool, mais qui sont un mécanisme mal connu.

(24:03 - 24:59)

On note l'encéphalopathie de Gaillet et Wernicke. L'alcool entraîne une carence en vitamine B1. Le syndrome de Korsakoff qui va se manifester par une amnésie entérograde, amnésie rétrograde, désorientation temporo-spatiale, défabulation aux fausses reconnaissances pour cacher ces amnésies et une absence ou bien un insight négatif défini par la nosognosie.

Donc le syndrome de Korsakoff peut aussi être vu de façon fréquente chez les psychiatres et chez les neurologues. Il y a les polynévrites alcoolico-carencielles, une carence vitaminique multiple. Les autres manifestations c'est l'épilepsie alcoolique, l'atrophie cérébelleuse, l'encéphalopathie de bigamie.

(25:01 - 25:37)

Les complications organiques autres que psychiatriques et neurologiques, donc sur les autres organes, il y a les cancers, les maladies cardiovasculaires, cirrhose du foie, les maladies du système nerveux, les troubles psychiques. Les autres complications, surtout chez la femme enceinte, il y a le syndrome d'alcoolisation fœtale qui va entraîner une multiplication, multiple

malformation, un retard de croissance en utéro, un retard de développement psychomoteur chez le bébé. La prise en charge commence d'abord par un examen biologique.

(25:38 - 26:05)

Elle est essentielle pour voir l'état du patient somatique et pour voir aussi le niveau d'alcoolisation. On peut doser le gamma-glutamyl transferase, le volume globulaire moyen, la transferrine distialylée qui est un indicateur de surconsommation. Donc on l'utilise surtout quand on donne à un patient une permission, au retour de la permission on peut la doser pour voir s'il a consommé ou pas.

(26:06 - 26:31)

Il y a aussi le dosage de l'alcoolémie qui peut se faire en urgence. Le dosage du taux d'alcool dans l'air expiré par l'étéromètre. Et les autres bilans pour voir le niveau, ou bien la sévérité de l'atteinte, notamment le bilan hépatique de la glycémie.

Donc on a vu que les peaux glycémiques fréquentent chez ces patients. Les bilans lipidiques aussi. Après il y a la prise en charge.

(26:32 - 26:44)

La prise en charge en aiguë. Il y a la prise en charge chronique, donc en aiguë. On va traiter les complications aiguës, notamment l'ivresse simple, qui va nécessiter le plus souvent du repos.

(26:44 - 27:09)

La réhydratation massive c'est très important, donc une observation de 2 à 3 heures. On va profiter pour faire un examen complet pour voir le retentissement pour rechercher les autres toxiques. Et si on a des troubles de comportement, on peut donner des benzodiazépines à faible dose dans ces cas, mais faire très attention parce que ces sujets peuvent tomber dans la dépendance aux benzodiazépines.

(27:10 - 27:34)

L'ivresse pathologique peut nécessiter des fois l'hospitalisation du patient pendant quelques heures. On peut donner des benzodiazépines s'il n'y a pas de sédation. On peut passer au neuroleptique sédatif et ne pas oublier la sensibilisation du malade, la psychoéducation du malade, mettre le malade sous vitaminothérapie et prévoir un projet thérapeutique à long terme.

(27:37 - 28:34)

La prise en charge de sevrage éthylique, donc d'abord nécessite une prise de conscience par le sujet, de la dépendance à l'alcool, la demande et la motivation pour le traitement, un bilan complet, un traitement en ambulatoire ou en hospitalier selon les cas, la prise en charge de la

psychoéducation de la famille et bien sûr la prise en charge par la suite des rechutes. Dans la prise en charge de la dépendance à l'alcool, il y a des médicaments qui vont aider à l'abstinence. J'insiste sur la différence entre deux types de médicaments.

Il y a les médicaments qui vont aider à l'abstinence et il y a les médicaments qui vont aider au sevrage. Les médicaments qui aident à l'abstinence, on note l'autal, le Revia et l'Espéral. Ces médicaments ne sont pas disponibles au Maroc mais tous les patients peuvent les ramener de l'étranger.

(28:35 - 28:58)

L'Espéral, c'est le médicament dissuasif dont je vous ai parlé tout à l'heure qui va dissuader le malade à la prise de l'alcool. Il le prend normalement le matin, au réveil, il sait si jamais il boit après la prise de ce médicament il va être dans un état désagréable qu'il n'aimerait pas vivre. Le deuxième type de médicaments, c'est les médicaments du sevrage.

(28:58 - 30:46)

Ils sont constitués en premier par les benzodiazépines. Quand on met le patient ce sevrage, soit volontairement, soit involontairement, on a décidé avec le patient une prise en charge d'abstinence, une prise en charge en cours, on va le mettre en sevrage et pour le couvrir contre les complications du sevrage, on va le mettre sous benzodiazépines. Des fois, on hospitalise le patient dans un service de réanimation ou bien un service de chirurgie pour une intervention chirurgicale et on le met automatiquement ce sevrage.

Donc là, il faut le mettre sous benzodiazépines. La prise en charge autre peut constituer par la carbamazépine, valproate de sodium, les bêtablocons et on peut utiliser des hypnotiques si on a une insomnie. Ne pas oublier chose capitale, la vitaminothérapie parce que ces patients vont présenter des complications neurologiques.

Donc on va donner de la vitamine B1, B6, B12 de l'acide folique pendant 8 jours puis on fait un relais, un comprimé de vitamine B1, B6, B12 3 fois par jour pendant 3 à 4 mois. Ne pas oublier aussi la prise en charge des troubles psychiatriques associés, notamment la prise en charge de l'anxiété, donc l'anxiété de sevrage, les symptômes anxieux par les benzodiazépines et il y a la prise en charge du trouble anxieux primaire caractérisé de TAG, le trouble de panique la phobie sociale, dont le traitement de base et les antidépresseurs. La prise en charge de la dépression aussi se fait de façon simultanée.

(30:47 - 31:00)

Des fois le sevrage total de l'alcool peut entraîner une amélioration de la dépression. Donc ça dépend des cas. On peut attendre quelques jours pour voir si ça va disparaître.

(31:00 - 31:30)

Si la dépression persiste avec un risque suicidaire, là il faut mettre le patient sous antidépresseur. Et bien sûr il y a les thérapies de groupe, les thérapies individuelles, les psychothérapies de soutien, l'ATCC, les thérapies motivationnelles, les thérapies de couple et l'association des anciens buveurs qui peuvent aider à la prise en charge et au sevrage. Maintenant on va passer à la complication de l'alcoolisme chronique.

(31:32 - 31:51)

Une des complications les plus graves qui se représentent par le délirium très mince qui constitue une urgence médico-psychiatrique et qui nécessite l'hospitalisation. Il se manifeste par un état confusionnel et délirant d'origine toxique. La durée est courte mais le pronostic vital est mis en jeu.

(31:51 - 32:13)

Donc l'intérêt capital de la prévention de cette pathologie. Les sujets à risque sont les alcooliques avec intoxication massive et ancienne, sevrage complet ou partiel, ou bien des fois suite à une alcoolisation massive. Il y a d'autres facteurs qui favorisent ce délirium très mince, notamment en cas de stress, traumatisme, infection chez un alcoolique chronique.

(32:14 - 32:37)

Le début est brutal. Parfois ça peut commencer par des prodromes de 2 à 4 jours par des signes qu'on appelle pré-délirium qui peuvent se manifester par des tremblements fins, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'agitation, de l'insomnie, de la fatigue, des signes physiques, sueur, tachycardie, diarrhée. On peut aussi noter de l'anorexie et la soif intense.

(32:38 - 33:22)

Après vient s'installer le délire onérique, aigu, qui va se manifester par des hallucinations visuelles sous forme de scénarios qui sont terrifiants avec des scènes de vie professionnelle avec angoisse et cauchemar. Donc le patient va voir des scènes vraiment très angoissantes et terrifiantes sous forme de monstres, sous forme d'animaux, sous forme de morts par exemple, des hallucinations auditives, des hallucinations sénestésiques, des sensations de toile d'araignée, de grumeaux de petits animaux sur le corps, des fourmis par exemple. Les thèmes sont terrifiants.

(33:22 - 33:39)

Donc ça peut être des zoopathies, thèmes de catastrophes, des thèmes de terreur et ça concerne le domaine professionnel, familial et problèmes conjugaux. On note une forte participation affective avec agitation. C'est un délire de rêve et d'action.

(33:39 - 33:59)

Imaginez, c'est comme si vous êtes dans un rêve et vous êtes éveillé, c'est-à-dire vous êtes en action dans votre rêve, comme si votre cauchemar est une réalité. Donc vous vivez un cauchemar et vous êtes en train de combattre les monstres que vous rencontrez dans votre cauchemar. Dans ce cas, le passage à l'acte est possible.

(34:00 - 34:25)

L'évolution de ce délire est variable dans la journée. On note aussi des signes neurologiques, donc des tremblements, de la désarterie, des troubles de l'équilibre, des troubles de la déglutition et de l'hypertonie. On note aussi de la confusion mentale et des signes généraux, type fièvre, sueur, déshydratation avec oligurie, tachycardie, hypotension.

(34:25 - 34:46)

Parfois on a des diarrhées et des vomissements. Au niveau biologique, on va voir une hypernatrémie, une hemoconcentration, hyperazotémie, macrocytose, augmentation des gamma-GT et une perturbation du bilan hépatique. L'évolution sous traitement est favorable, mais le traitement doit être rapide et urgent.

(34:47 - 35:30)

Sans traitement, l'évolution est fatale par un collapsus, par un coma hépatique ou par des troubles métaboliques, notamment l'hypoglycémie, l'hypernatrémie, l'hypercaliémie. L'hospitalisation d'office dans une chambre semi-éclairée, il ne faut pas mettre de contention parce que le patient est confus, on va augmenter l'angoisse du patient, avoir des attitudes rassurantes, mais le plus important, c'est de faire en urgence un bilan paraclinique pour voir la glycémie, le bilan lipidique, les troubles hydroélectrolytiques qu'il faut corriger en urgence. La réhydratation doit être massive et urgente, 5 à 6 litres par jour, avec des sels minéraux et du sucre.

(35:31 - 36:00)

Et en cas de troubles hydroélectrolytiques, il faut une rééquilibration hydroélectrolytique. Des fois, le patient peut nécessiter la réanimation si on a des troubles graves. Le traitement sédatif pour les agitations, on peut utiliser des benzodiazépines, des neuroleptiques sédatifs, et en cas de délire et d'hallucination, on peut utiliser des neuroleptiques atypiques ou de l'aldol, des neuroleptiques classiques si on n'a pas les neuroleptiques atypiques.

(36:02 - 36:30)

La vitaminothérapie, elle est capitale, on a dit de faire attention aux complications neurologiques, la surveillance du patient par la suite, et bien sûr, si on a une infection, il faut traiter par les

antibiotiques. Le traitement de la dépendance à l'alcool, le proposer à la sortie du patient, et bien sûr, essayer de motiver le patient pour une psychothérapie et pour une abstinence. Merci.